

接骨消肿止痛散外敷治疗软组织损伤 587 例

黄璇

(云南省禄丰县人民医院 中医科, 云南 禄丰 651200)

关键词: 软组织损伤; 伤筋; 中药外敷; 接骨消肿止痛散

中图分类号: R274.3 **文献标识码:** D **文章编号:** 1006-978X(2003)06-0031-01

软组织损伤属中医“伤筋”范畴, 是骨伤科临床的常见病、多发病, 笔者于 2000 年 2 月~2002 年 12 月间, 采用接骨消肿止痛散外敷治疗组织损伤 587 例, 取得较好疗效, 现报道如下。

1 临床资料

本组病例 587 例, 其中男 389 例, 女 198 例; 年龄最大 72 岁, 最小 1 $\frac{3}{12}$ 岁; 病程最短 1 h, 最长 12 d; 肩臂部挫伤 33 例, 肘关节挫伤 90 例, 前臂挫伤 96 例, 手掌腕部挫伤 58 例, 膝关节挫伤 112 例, 小腿部挫伤 42 例, 踝关节及足部挫伤 117 例, 胸部挫伤 39 例; 均为门诊病例。

2 治疗方法

2.1 方药制作 大黄 5 kg, 栀子 3 kg, 乳香 3 kg, 没药 3 kg, 虎杖 3 kg, 红花 1 kg, 大红袍 3 kg, 五爪金龙 5 kg, 接骨草 5 kg, 龙胆草 3 kg, 天花粉 5 kg, 蛇床子 3 kg, 地肤子 3 kg, 重楼 5 kg, 白芨 5 kg, 将上药研细, 过 100 目筛, 封藏备用。

2.2 治疗方法 视伤处面积大小取药粉加开水拌湿, 搅均匀, 摊在大于患部的纱布上, 贴敷患处, 四肢可用绷带包扎, 胸部及肩部可用棉敷料覆盖, 再用宽胶布粘贴, 敷药处干后每天可用白酒(小儿高敏皮肤者用温热水)隔缚带浸湿一次, 隔 3 d 换药 1 次, 直至痊愈。

3 治疗结果

3.1 疗效标准 痊愈: 肿胀消失, 局部瘀血消散, 恢复正常功能; 有效: 疼痛、肿胀基本消失, 局部瘀血消散, 活动量加重时仍感疼痛; 无效: 局部症状、体征及肢体功能无明显改变。

3.2 治疗结果 587 例患者中, 痊愈 538 例, 占 91.65%; 有效 49 例, 占 8.35%; 无效为 0。总有效率 100%。

4 典型病例

3.1 疗效标准 痊愈为各种症状消失, 恢复正常生活与工作; 好转为治疗后症状减轻, 能坚持一般工作; 无效为治疗后症状无明显改善或加重者。

3.2 结果 23 例中, 痊愈 11 例, 好转 12 例, 无效 0 例。以上患者平均治疗 3.5 个疗程。

4 讨论

4.1 本病多为暴力、外伤所致, 如关节突骨折、峡部骨折, 或是峡部发育不全, 先天断裂, 加之劳损或外伤引起椎体离解而滑脱, 此类患者多伴有腰、骶椎隐裂, 由于横韧带的断裂或前纵韧带的松弛而引起椎体滑脱。因腰椎结构复杂, 滑脱后不易复位, 轻者腰腿痛, 重者还可能引起下肢瘫痪, 故西医多主张带腰围保护或手术融合, 防止继续滑脱。笔者认为如无下肢瘫痪或大小便失禁者, 均可试用推拿治疗, 一般腰腿痛症状大多可推拿治愈

朱××, 女, 46 岁, 患者因下楼不慎踩空, 致左踝关节扭伤。查: 左踝关节肿胀、疼痛, 皮肤青紫, 行动不便, 经 X 片摄片未见异常, 诊断为左踝关节扭伤, 予以“接骨消肿止痛散”依法外敷, 并嘱患者注意休息, 抬高患肢。敷药 3 d 后肿消痛止, 瘀斑变浅, 已能行走, 又敷药 3 d 后症状完全消失, 行走如常。

5 体会

软组织损伤, 属中医“伤筋”范畴, 是中医骨伤科门诊最常见的多发病。《医宗金鉴·正骨心法要旨》说: “跌打损伤之症, 专从血论”。说明跌打损伤主要临床表现和症状为疼痛、肿胀, 治疗必须以活血散瘀、消肿止痛为主。气血凝滞, 或阻于肌肉、或留于筋骨, 久则郁而化热, 致使血肉腐败, 酝酿液化成脓, 故早期治疗必须逐瘀泄热、消肿止痛以防病传。现代医学认为其主要产生原因是外伤性炎症反应, 损伤后由于组织出血、体液渗出, 同时由于疼痛反射性造成肌肉痉挛, 静脉及淋巴管瘀滞, 回流障碍, 造成组织间水肿。方中用大黄、白芨以活血祛瘀消肿, 止血定痛; 乳香、没药以活血伸筋, 散血化瘀消肿; 红花活血化瘀消肿; 栀子、虎杖、天花粉、龙胆草、重楼活血定痛, 清热解暑消肿, 抗炎解痉, 可减少体内创伤组织渗出物, 并能促其迅速吸收; 大红袍、五爪金龙、接骨草止血除瘀, 消炎肿, 接筋骨; 蛇床子、地肤子清热利湿, 祛风止痒, 可防止部分患者因用药物刺激而出现的过敏性皮疹。诸药合用, 清热解毒、活血化瘀、消肿止痛、消除局部软组织炎症、减少局部组织液渗出、修复毛细血管破裂、改善患部微循环, 从而达到根治软伤的目的。此方具有取效迅速、消肿止痛快、疗效显著、制作取材简单、无毒副作用等特点, 宜推广应用。

收稿日期: 2003-08-29

或减轻。但需注意治疗时切勿用强力牵引及腰部后伸扳法, 防止症状加重。

4.2 本推拿治疗的作用, 不可能要求所有滑脱的椎体完全复位, 而是要达到促进局部血液循环、消炎止痛、舒筋通络的目的。治疗时点按天宗穴为笔者之经验穴, 对腰部痛症, 特别是急性损伤者点按此穴有奇效。按压滚腰法是根据生物力学原理, 当患者极度屈膝屈髋滚动时, 腰椎处于向前屈曲位, 椎体的后纵韧带、棘上韧带、棘间韧带均处于紧张牵拉状态, 产生迫使椎体后移的拉力, 有促使滑脱椎体后移的作用。用此法治疗本病虽未能使大部分患者椎体复位(本组患者中有 4 例治疗后椎体有部分复位), 但临床疗效还较满意。因笔者观察的病例较少, 能否使椎体完全复位, 尚有待进一步研究。

收稿日期: 2003-08-22